

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

TEST DE CRIBADO DE SOMATIZACIÓN DE OTHMER Y DESOUBA

Screening Test for Somatization Disorder (Othmer & DeSouza, 1985) · Adaptación Hispanoparlante

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Test de Detección del Trastorno de Somatización de Othmer y DeSouza (Screening Test for Somatization)
Sigla / Acrónimo	Othmer-DeSouza (SODT)
Autoría original	Ekkehard Othmer & Celso DeSouza (Department of Psychiatry, Univ. of Kansas Medical Center, 1985)
Adaptación en español	Versión instrumental en castellano de uso clínico en psicopatología y atención primaria
Constructo evaluado	Cribado ultrarrápido de somatización crónica, polisintomatología somatomorfa y multiconsulta médica
Población diana	Adultos policonsultantes con múltiples quejas somáticas sin causa médica orgánica explicativa identificada
Tiempo de aplicación	2 a 3 minutos (heteroadministrado o autoadministrado en sala de espera)
Estructura y formato	6 ítems dicotómicos (Sí / No) representativos de órganos y sistemas somáticos clave
Condiciones de uso	Dominio público para práctica asistencial y cribado clínico no comercial citando a los autores

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El trastorno de somatización (históricamente síndrome de Briquet y actualmente categorizado dentro del Trastorno de Síntomas Somáticos en el DSM-5) se caracteriza por un patrón crónico y persistente de múltiples quejas físicas no explicadas por una patología médica objetivable. Estos pacientes suelen someterse a hospitalizaciones reiteradas, pruebas diagnósticas invasivas y cirugías innecesarias, con una severa iatrogenia secundaria y un elevado coste sanitario.

Los criterios diagnósticos clásicos (DSM-III/DSM-IV) requerían la verificación exhaustiva de hasta 35 síntomas en cuatro grupos orgánicos diferentes, lo que hacía su cribado inviable en la práctica clínica diaria de atención primaria y urgencias. Mediante rigurosos análisis de regresión logística y discriminante, Othmer y DeSouza (1985) demostraron que un conjunto reducido de solo **6 síntomas físicos altamente específicos** permitía predecir con una exactitud diagnóstica superior al 90% la presencia del cuadro completo de somatización crónica.

3. ÍTEMS CRÍTICOS Y LOCALIZACIÓN ORGÁNICA

Ítem	Síntoma Físico Exploratorio	Respuesta	Significación Clínica Psicopatológica
1	Dificultades para respirar (disnea sin esfuerzo)	Sí = 1 / No = 0	Hiperventilación, ansiedad somatizada y espasmo torácico
2	Sensación de nudo o cierre en la garganta	Sí = 1 / No = 0	Globo histérico clásico / espasmo esofágico funcional
3	Vómitos frecuentes (no asociados a embarazo)	Sí = 1 / No = 0	Disfunción gastrointestinal funcional y somatomorfa
4	Dolores intensos en dedos de manos o pies	Sí = 1 / No = 0	Dolor periférico difuso musculoesquelético / acroparestesias
5	Dolores menstruales severos / molestias genitales	Sí = 1 / No = 0	Dismenorrea incapacitante funcional / dolor pélvico crónico
6	Lapsus o pérdidas notables de memoria (amnesia)	Sí = 1 / No = 0	Disociación pseudoneurológica y sobrecarga cognitiva

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS (RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO)

Sensibilidad clínica	Sensibilidad del 89% para la detección del trastorno de somatización formal en muestras ambulatorias psiquiátricas y médicas con punto de corte ≥ 2 síntomas afirmativos.
Especificidad diagnóstica	Especificidad del 98% frente a sujetos control y pacientes con enfermedades médicas crónicas orgánicas bien delimitadas.
Valor predictivo positivo	VPP del 88 — 92% en poblaciones de atención primaria con alta tasa de policonsultas no explicadas.
Valor predictivo negativo	VPN del 97 — 99%; una puntuación < 2 descarta con alta certeza el trastorno de somatización de Briquet.
Correlato con multiconsulta	Correlación positiva significativa ($r = 0.58$, $p < 0.001$) con el número de ingresos hospitalarios previos, cirugías exploratorias en blanco y recetas psicofarmacológicas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Criterio de positividad	Un síntoma solo debe puntuarse como afirmativo (1 punto) si ha estado presente de manera repetida y no tiene una causa médica orgánica confirmada.
Puntuación directa global	Suma aritmética simple de las respuestas afirmativas. Rango teórico posible: 0 a 6 puntos .
Ajuste por género	En varones, el ítem 5 (dolores menstruales) se evalúa indagando molestias en órganos genitales/recto (disuria psicógena, dolor testicular funcional).
Tiempo requerido	Menos de 2 minutos de aplicación directa en el triaje de atención primaria o consulta de enlace.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Probabilidad	Estrato Clínico	Significación y Conducta Recomendada
0 - 1	$< 5\%$	Negativo / Baja Probabilidad	Patrón somático ordinario. Descarta somatización severa.
2	75 - 80%	Cribado Positivo / Sospecha	Indica sospecha fundada; aplicar entrevista clínica formal.
3 - 4	$> 90\%$	Alta Probabilidad de Somatización	Cuadro polisintomático complejo; riesgo elevado de iatrogenia.
5 - 6	$> 98\%$	Somatización Severa / Briquet	Casi certeza de trastorno de somatización florido y crónico.

PUNTO DE CORTE CRÍTICO:

- **Puntuación ≥ 2 Síntomas:** Cribado **positivo** para trastorno de somatización. Exige frenar la solicitud indiscriminada de pruebas diagnósticas complementarias innecesarias e instaurar un modelo de manejo con médico de cabecera único y citas programadas regulares.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN EN PACIENTES POLICONSULTANTES

Paso 1: Cribado en Policonsultante: Aplicar los 6 ítems de Othmer-DeSouza ante paciente con historial extenso de pruebas negativas.

Paso 2: Si Puntuación < 2: Explorar diagnósticos diferenciales médicos estándar o trastorno de pánico/ansiedad aislada.

Paso 3: Si Puntuación ≥ 2 (Cribado Positivo):

- **Asignación de Médico de Referencia Único:** Centralizar la atención en un solo profesional de atención primaria para evitar shopping médico.
- **Citas Regulares Programadas:** Establecer consultas quincenales o mensuales de 15 minutos **fijas**, independientemente de que el paciente tenga síntomas agudos o no, desvinculando la atención médica de la intensificación del síntoma.
- **Evitar Pruebas Complementarias Agresivas:** Realizar examen físico focalizado breve para tranquilizar al paciente, pero no solicitar pruebas invasivas salvo hallazgos objetivos categóricos nuevos.

Paso 4: Coordinación con Salud Mental: Introducir psicoterapia cognitivo-conductual centrada en el manejo de la angustia somática y validación empática del sufrimiento real.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ENLACE

Identificación: Mujer de 41 años, remitida a la consulta de interconsulta y enlace tras acudir en 14 ocasiones a urgencias en el último año por disnea súbita, dolor en extremidades, vómitos y disfagia. Ha acumulado 3 endoscopias, 2 TAC de tórax y múltiples analíticas sin hallazgos patológicos.

Evaluación Othmer-DeSouza: Puntuación total = **4 / 6** (Alta Probabilidad de Somatización).

- Ítems positivos: Falta de aire sin causa pulmonar (Sí = 1); Sensación de nudo en la garganta (Sí = 1); Vómitos repetidos sin gastritis (Sí = 1); Dolores en dedos y pies (Sí = 1).

Intervención Terapéutica: Se consensuó con su médico de cabecera una estrategia de visitas regulares programadas cada 3 semanas, validando su malestar físico sin solicitar nuevas pruebas redundantes. En psiquiatría se inició terapia cognitivo-conductual centrada en la tolerancia al malestar y reestructuración de catastrofismo somático.

Seguimiento a los 6 meses: Reducción del 85% en las visitas a urgencias (0 visitas en los últimos 4 meses), mejoría en la funcionalidad laboral y estabilización del vínculo con su médico de familia.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo de Iatrogenia:

- **Cirugías Innecesarias:** Riesgo elevado de laparotomías blancas o procedimientos invasivos por persistencia de quejas viscerales.
- **Cáncer Oculto o Enfermedades Autoinmunes:** Descartar siempre lupus, esclerosis múltiple o neoplasias antes de catalogar los síntomas como puramente psico-somáticos si hay pérdida de peso o fiebre.

Diagnóstico Diferencial:

- **Trastorno de Ansiedad por Enfermedad (Hipocondría):** Preocupación centrada en tener una enfermedad grave específica más que en la multiplicidad de síntomas corporales.
- **Trastorno Facticio / Simulación:** Producción intencionada de síntomas motivada por asumir el rol de enfermo o por ganancia secundaria externa.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Othmer, E., & DeSouza, C. (1985). A screening test for somatization disorder (hysteria). *The American Journal of Psychiatry*, 142(10), 1146-1149. <https://doi.org/10.1176/ajp.142.10.1146>
- Smith, G. R., Monson, R. A., & Ray, D. C. (1986). Psychiatric consultation in somatization disorder: A randomized controlled study. *The New England Journal of Medicine*, 314(22), 1407-1413.
- deGruy, F., Columbia, L., & Dickinson, P. (1987). Somatization disorder in a family practice. *The Journal of Family Practice*, 25(1), 45-51.
- Fink, P., Rosendal, M., & Olesen, F. (2005). Classification of somatization and functional somatic symptoms in primary care. *The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 39(9), 772-781.